

CAPÍTULO 13.54

Cáncer Nasosinusal y de Boca

PERFIL EUNACOM 1.13.54

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El **cuerpo extraño (CE) en la vía aérea** es una de las emergencias médicas más críticas, especialmente en la población pediátrica. La rapidez en el diagnóstico y la ejecución de las maniobras de desobstrucción pueden determinar la supervivencia del paciente. Clínicamente, se divide según su ubicación en **laríngeo** (vía aérea superior) y **bronquial** (vía aérea inferior).

1. Cuerpo Extraño Laríngeo (Obstrucción de Vía Aérea Superior)

Es una urgencia extrema. La laringe es el punto más estrecho de la vía aérea superior en niños, por lo que un objeto impactado aquí puede causar una **obstrucción completa** y la muerte inmediata por asfixia.

Clínica de la Obstrucción

Es fundamental diferenciar entre una obstrucción total y una parcial para determinar el manejo:

- **Obstrucción Total (Signos de alarma):**
 - Imposibilidad de hablar, llorar o toser.
 - Incapacidad para respirar.
 - Signo universal de asfixia (manos al cuello).
 - Cianosis rápida y pérdida de conciencia.
- **Obstrucción Parcial (No obstructivo):**
 - El paciente **puede hablar**, toser con fuerza o llorar.
 - Si el paciente dice "me estoy ahogando", significa que está movilizándolo.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

¡CUIDADO! Si el paciente tiene una obstrucción parcial (puede hablar o toser), **NO** se debe realizar la maniobra de Heimlich. El movimiento brusco podría desplazar el objeto y convertir la obstrucción en total. En estos casos, se debe calmar al paciente, fomentar la tos espontánea y derivar de inmediato a un servicio de urgencia para extracción bajo visión directa.

Manejo de la Obstrucción Total

El tratamiento de elección depende de la edad del paciente:

TABLA 13.54.1: GRUPO ETARIO VS MANIOBRA DE ELECCIÓN

GRUPO ETARIO	MANIOBRA DE ELECCIÓN	TÉCNICA
Menores de 1 año (Lactantes)	Golpes interescapulares y compresiones torácicas	5 golpes en la espalda (boca abajo) + 5 compresiones en el tórax (boca arriba). Repetir hasta que salga el objeto o el niño pierda la conciencia.
Mayores de 1 año y Adultos	Maniobra de Heimlich	El reanimador se sitúa detrás del paciente, abraza su cintura y coloca el puño bajo la apófisis xifoides, presionando con fuerza hacia atrás y hacia arriba (en forma de "J").
Pacientes Obesos o Embarazadas	Compresiones torácicas	Si el diámetro abdominal impide el Heimlich, se realizan compresiones en el centro del esternón.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Si un paciente con obstrucción total pierde la conciencia, se debe iniciar de inmediato el protocolo de **RCP básico**, ya que las compresiones torácicas generan una presión intratorácica que puede ayudar a expulsar el cuerpo extraño.

2. Cuerpo Extraño Bronquial (Vía Aérea Inferior)

Es más frecuente que el laríngeo y suele presentarse en niños pequeños que aspiran alimentos (frutos secos) o piezas pequeñas de juguetes.

El Síndrome de Penetración

Es el evento inicial clave en la anamnesis. Se define como un episodio brusco de **tos súbita, intensa y en accesos** (paroxística) mientras el niño comía o jugaba.

- A menudo, tras este episodio inicial, hay un "periodo de silencio" donde la tos disminuye, lo que puede llevar a los padres a pensar que el peligro pasó.
- En muchos casos, el accidente no es presenciado por adultos, lo que retrasa el diagnóstico.

Cuadro Clínico Posterior

Si el CE no se extrae, el paciente puede evolucionar con: - Tos persistente o crónica. - **Neumonía recurrente** en el mismo lóbulo. - **Asma de difícil manejo:** Sospechar siempre un cuerpo extraño en un niño con sibilancias que no responde al tratamiento broncodilatador habitual. - **Examen Físico:** Disminución localizada del **murmulo pulmonar**, sibilancias localizadas y, a veces, crépitos.

NOTA CLÍNICA

Anatomía: El lugar más frecuente de impactación es el **bronquio fuente derecho**. Esto se debe a que el bronquio derecho es más vertical, más corto y de mayor calibre que el izquierdo, siguiendo la dirección de la tráquea y facilitando el paso de objetos por gravedad.

3. Diagnóstico por Imágenes

Ante la sospecha de un CE bronquial, el estudio inicial es la **Radiografía de Tórax** (en inspiración y espiración si es posible).

Hallazgos Radiológicos

Dependen de si el objeto es radiopaco o radiolúcido y del grado de obstrucción:

- **Cuerpo Extraño Radiopaco:** Se ve directamente el objeto (monedas, pilas, piezas metálicas). Solo ocurre en el 10-20% de los casos.
- **Cuerpo Extraño Radiolúcido (Orgánicos):** No se ve el objeto, pero se ven sus efectos indirectos:
 - **Enfisema obstructivo (Hiperinsuflación):** Ocurre por un "efecto valvular" (el aire entra pero no sale). Se observa un pulmón o lóbulo más negro y con aumento de volumen.
 - **Atelectasia:** Ocurre por obstrucción completa. El aire distal se absorbe y el pulmón se colapsa.
 - **Desviación del mediastino:** En espiración, el mediastino se aleja del lado afectado si hay hiperinsuflación.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Una radiografía normal **NO** descarta un cuerpo extraño si la sospecha clínica es alta. Si la clínica manda, el siguiente paso es la **broncoscopia**.

4. Manejo Definitivo

El estándar de oro tanto para el diagnóstico definitivo como para el tratamiento es la **Broncoscopia**.

- **Broncoscopia Rígida:** Es la técnica de elección para la extracción de cuerpos extraños en pediatría, ya que permite un mejor control de la vía aérea y el uso de pinzas especializadas.
- **Broncoscopia Flexible:** Útil para diagnóstico en casos dudosos o cuando el CE está en bronquios muy distales.

Resumen de la Conducta

1. **Sospecha clínica clara (Síndrome de penetración):** Ir directo a broncoscopía, incluso con Rx normal. 2. **Duda diagnóstica:** Se puede solicitar una **Tomografía Computarizada (TAC)** de tórax, que tiene alta sensibilidad para detectar objetos radiolúcidos. 3.

Extracción: Siempre debe realizarse en un entorno controlado (pabellón) por especialistas (broncopulmonares o cirujanos infantiles).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Nunca intente extraer un cuerpo extraño a ciegas con los dedos (barrido digital), ya que esto puede empujar el objeto más profundamente o causar un edema laríngeo que agrave la situación.

- **Enlaces relacionados:**
- **Insuficiencia Respiratoria**
- **Sibilancias en el Pediatra**
- **Paro Cardiorespiratorio**

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Hombre de 60 años, fumador, consulta por obstrucción nasal izquierda progresiva de 3 meses, epistaxis recurrente ipsilateral y dolor facial. Al examen se observa proptosis del ojo izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Cáncer Nasosinusal y de Boca. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Cáncer nasosinusal: dolor facial/dental + obstrucción nasal unilateral + epistaxis o secreción cerosanguinolenta/hemopurulenta.
- Invasión orbitaria frecuente: estrabismo, proptosis y otras alteraciones oculares (senos paranasales limitan con la órbita).
- Estudio: rinoscopía (visualización + biopsia) + TAC (invasión ósea) o RMN (partes blandas y tumores ocultos en senos paranasales).
- Cáncer de boca: lesión heterogénea, ulcerada, de crecimiento LENTO. Úlcera de rápida instalación → infeccioso/inflamatorio.
- Factor de riesgo principal: tabaquismo. También VPH en pacientes VIH.
- Localización más frecuente del cáncer de boca: lengua.
- Leucoplasia (placa blanca) y eritroplasia (placa roja): lesiones premalignas de la mucosa oral.
- Eritroplaquia tiene ~90% de probabilidad de malignidad (cáncer establecido o displasia severa).
- Lesión premaligna sin cáncer → crioterapia. Si ya hay cáncer o lesión muy grande → cirugía + manejo oncológico completo.
- Lesión premaligna no requiere disección cervical ni quimio/radio. Cáncer confirmado sí requiere manejo completo.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CÁNCER NASOSINUSAL Y DE BOCA)

PREGUNTA 1

Hombre de 60 años, fumador, consulta por obstrucción nasal izquierda progresiva de 3 meses, epistaxis recurrente ipsilateral y dolor facial. Al examen se observa proptosis del ojo izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Sinusitis crónica complicada
- B) Cáncer nasosinusal con invasión orbitaria
- C) Pólipo nasal antrocoanal gigante
- D) Granulomatosis con poliangeítis (Wegener)
- E) Celulitis orbitaria

PREGUNTA 2

Paciente de 50 años consulta por una lesión roja, ligeramente sobreelevada, en la mucosa del piso de la boca, de 2 cm, que ha crecido lentamente en los últimos 4 meses. Es fumador de 25 paquetes-año. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Observación y control en 3 meses
- B) Crioterapia con nitrógeno líquido directamente
- C) Biopsia de la lesión
- D) Antimicóticos tópicos por sospecha de candidiasis oral
- E) Iniciar quimioterapia neoadyuvante

PREGUNTA 3

Respecto a las lesiones premalignas de la mucosa oral, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A) La leucoplaquia tiene mayor riesgo de malignidad que la eritroplaquia
- B) Ambas lesiones requieren siempre resección quirúrgica amplia con disección cervical
- C) La eritroplaquia tiene aproximadamente 90% de probabilidad de contener cáncer o displasia severa
- D) Las lesiones premalignas solo aparecen en fumadores
- E) La localización más frecuente de estas lesiones es el paladar duro

RESUMEN: CÁNCER NASOSINUSAL Y DE BOCA

El cáncer nasosinusal (de nariz y senos paranasales) se presenta con dolor facial o dental (por invasión de estructuras faciales y raíces nerviosas/dentales), obstrucción nasal habitualmente unilateral y epistaxis o secreción cerosanguinolenta/hemopurulenta. Es frecuente la invasión orbitaria por la relación anatómica de los senos paranasales con la órbita, manifestándose con estrabismo, proptosis y otras alteraciones oculares. El estudio se inicia con rinoscopía para visualizar y biopsiar el tumor, complementado con TAC (mejor para invasión ósea) o RMN (mejor para partes blandas). Cuando no se encuentra en la rinoscopía, la RMN puede localizar tumores ocultos dentro de los senos paranasales. El cáncer de boca se presenta como una lesión heterogénea, ulcerada, de crecimiento lento. Una úlcera de rápida instalación sugiere proceso infeccioso o inflamatorio, mientras que una de crecimiento lento que se ulcera sugiere cáncer, especialmente con antecedente de tabaquismo. También se asocia a infección por VPH en pacientes VIH. La localización más frecuente es la lengua, aunque puede aparecer en labios, mejillas, paladar o cualquier parte de la mucosa oral. Las lesiones premalignas de la boca son la leucoplasia/leucoplaquia (placa blanca) y la eritroplasia/eritroplaquia (placa roja). La eritroplaquia tiene mayor probabilidad de malignidad (cerca del 90% viene con cáncer establecido o displasia severa). El enfrentamiento es siempre con biopsia. Si es premaligna sin cáncer, se puede manejar con crioterapia (nitrógeno líquido); si ya hay cáncer o la lesión es muy grande, se realiza resección quirúrgica con el manejo oncológico completo (disección cervical + quimio/radioterapia).